

***TUMEFACTIONS
PAROTIDIENNES
13/04/2026***

**Pr HEMMAOUI B
Service ORL ET CCF HMIMV RABAT**

Introduction

Une tuméfaction parotidienne se définit comme une augmentation de volume de la région parotidienne.



Introduction:

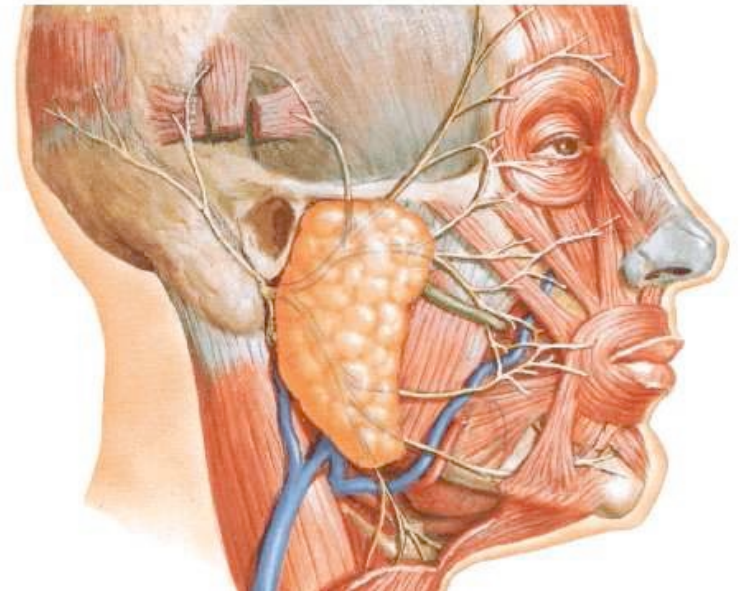
- ❖ La pathologie parotidienne est le plus souvent unilatérale
 - La pathologie tumorale bénigne ou maligne.
 - La pathologie infectieuse : parotidites aiguës virales, bactériennes ou lithiasiques, parotidites chroniques, est plus rare.
 - La lithiase parotidienne est beaucoup moins fréquente que la lithiase sous-mandibulaire.

Introduction:

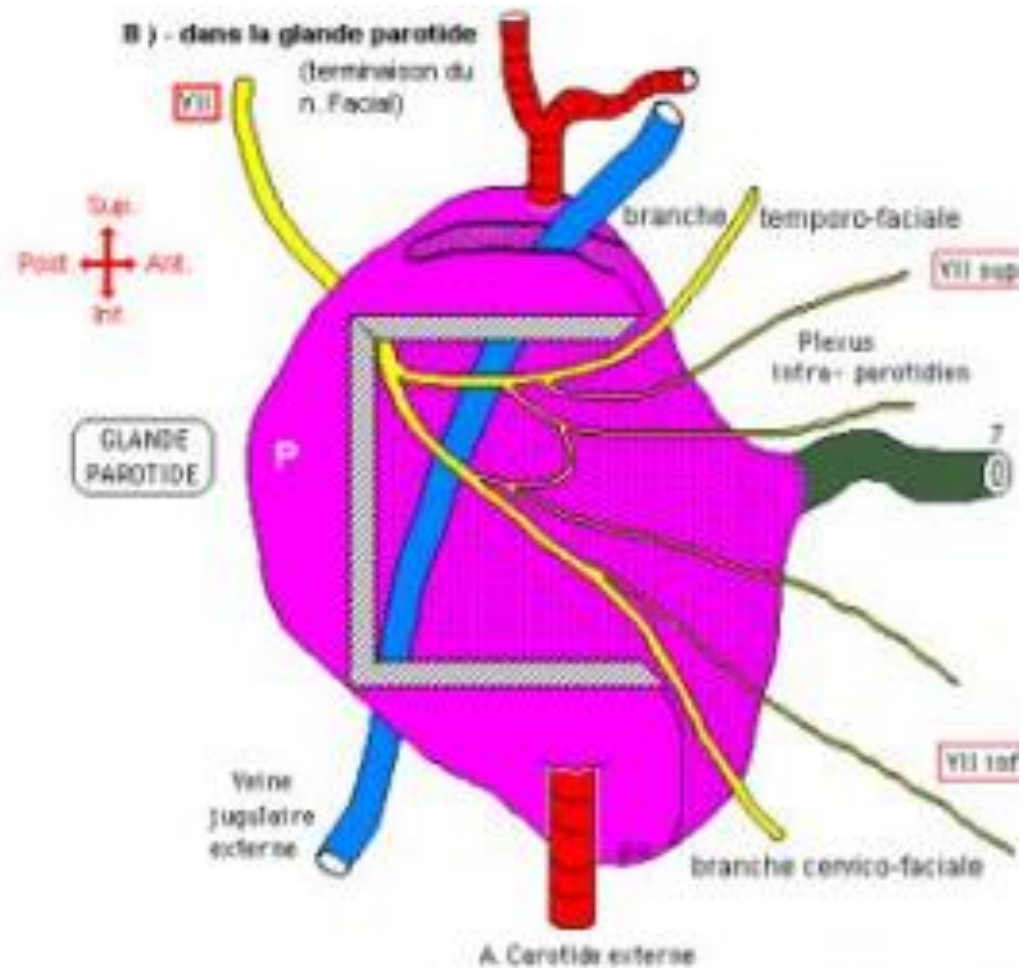
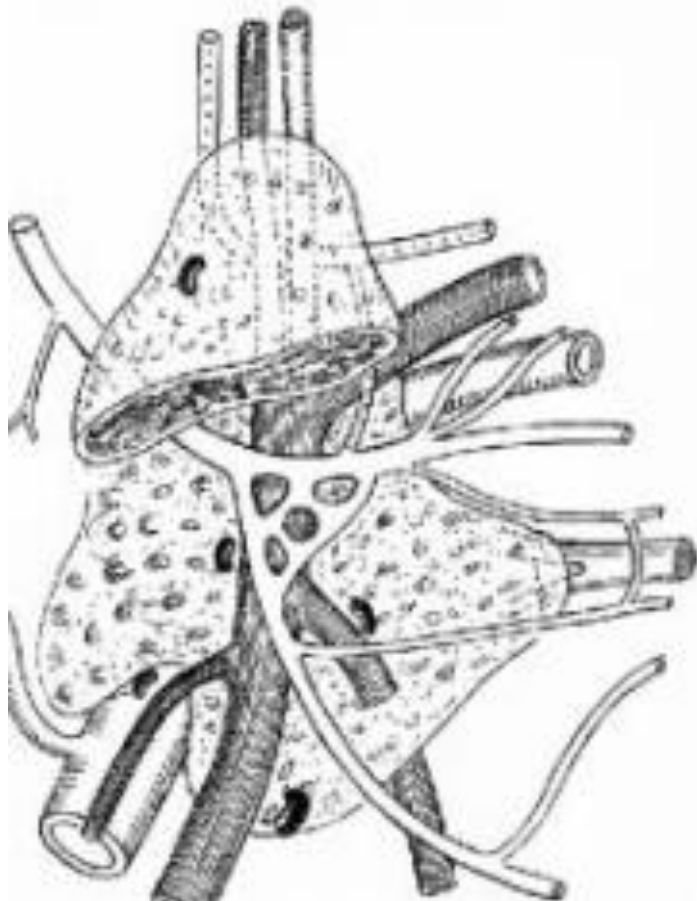
- ❖ Les tuméfactions parotidiennes bilatérales peuvent s'intégrer dans le cadre d'une maladie de système ou d'une calcinose salivaire. Les autres causes sont nutritionnelles ou toxiques.

INTRODUCTION

- En avant de l'apophyse mastoïde et le muscle sterno-cléido-mastoïdien ;
 - En haut par le conduit auditif externe et la portion postérieure de l'arcade zygomatique ;
 - En bas par une ligne horizontale allant de la mastoïde à l'angle de la mandibule ;
 - En profondeur par l'apophyse styloïde et l'espace latéro-pharyngien.



La région parotidienne, traversée par le canal de Sténon, l'artère carotide externe, le confluent veineux parotidien, le nerf facial.



I- CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE:

- Découverte fortuite par le patient ou le médecin d'une tuméfaction parotidienne ;
- Tuméfaction parotidienne douloureuse déclenchée par l'alimentation ;
- Tuméfaction parotidienne douloureuse dans un tableau infectieux

II- DIAGNOSTIC CLINIQUE:

1. INTERROGATOIRE: doit préciser :

- Age
- Habitudes alimentaires, la notion d'une intoxication alcoolique ;
- L'existence d'une pathologie rhumatismale, pulmonaire ou hématologique connue ;
- Notion d'une radiothérapie cervicale ;
- ATCDS chirurgicaux ;

II- DIAGNOSTIC CLINIQUE:

1. INTERROGATOIRE: doit préciser :

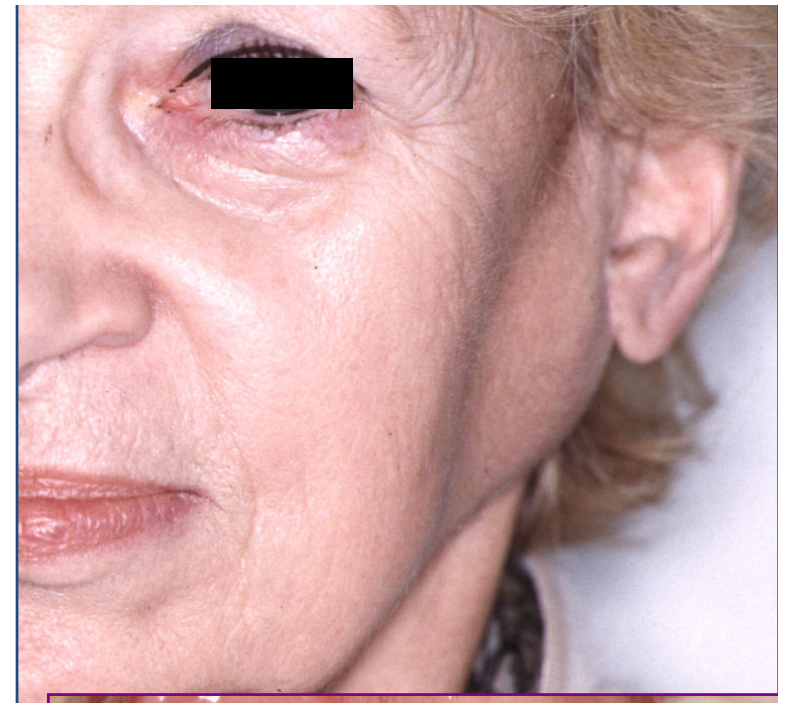
- Notion d'un traumatisme sur la région parotidienne ;
- Date de début
- le mode évolutif de la tuméfaction,
- les variations du volume de la tuméfaction avec l'alimentation ;
- Signes associés :
 - Douleur de la région parotidienne et rapport de la douleur avec l'alimentation,
 - Sécheresse buccale ou oculaire,
 - Asymétrie faciale.

II DIAGNOSTIC CLINIQUE

2. EXAMEN CLINIQUE

Inspection:

- Tuméfaction parotidienne comblant le sillon rétro-mandibulaire puis soulève en dehors le lobule de l'oreille,
- L'état de la peau en regard de la tuméfaction,
- Paralysie faciale,
- Examen endobuccal et dentaire est indispensable: aspect de l'ostium du canal de Sténon et de la salive, abondante ou rare, claire ou purulente,



II- DIAGNOSTIC CLINIQUE

Palpation: - permet de confirmer le siège parotidien de la tuméfaction et ses rapport

- Taille, surface lisse ou irrégulière, limites, consistance, sensibilité, douleur provoquée, mobilité par rapport à la peau et aux plans profonds.

- Un écoulement à l'orifice endobuccal du canal de Sténon ;

II- DIAGNOSTIC CLINIQUE

Palpation:

- Une tuméfaction sur le trajet du canal de Sténon
(palpation bimanuelle avec un doigt endobuccal).
- palpation de toutes les aires ganglionnaires cervicales à la recherche d'adénopathies associées.
- otoscopie doit être systématique,

III- DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

1. KYSTES DERMOÏDES ET KYSTES SÉBACÉS PRÉTRAGIENS

- Mobiles sur le plan parotidien profond.
- La cytoponction et l'écho aident au Dg différentiel.
- Le diagnostic est parfois chirurgical.

2. ADÉNOPATHIES SOUS-DIGASTRIQUES

- Une adénopathie sous-digastrique peut parfois être confondue avec une tumeur du pôle inférieur de la parotide.
- L'examen, tête en hyperextension, permet en général de localiser le siège sous-angulomandibulaire de la tuméfaction.

IV- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

1. PONCTION CYTOLOGIQUE

- moyen de diagnostic simple, rapide, peu traumatisant, sensible et peu coûteux,
- intéressant dans la pathologie tumorale.
- n'a de valeur que si elle est positive ;
- un cytologiste expérimenté.
- pas de risque de dissémination cellulaire tumorale ou de lésion du nerf facial, contrairement à la biopsie qui est formellement contre-indiquée.

IV- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

2. RADIOGRAPHIES STANDARD

- intérêt dans la lithiase salivaire, peu fréquente au niveau de la parotide.

3. SIALOGRAPHIE

- Opacification du système canalaire par un produit de contraste, injecté par le canal de Sténon.

- Son intérêt est limité dans la pathologie tumorale car elle ne visualise la tumeur que par des signes indirects de déplacement des canaux salivaires.

IV- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

3- Scintigraphie au technétium 99m :

- Fixation sur les glandes salivaires du 99mTc, après administration intraveineuse.
- Seules les tumeurs dont la taille est supérieur à 1,5cm sont visualisées.
- **Le cystadéno-lymphome papillaire** est la seule tumeur capable de fixer le 99mTc de façon précoce, intense et durable.

IV- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

4- Echographie :

- Exploration du lobe superficiel de la parotide,
- Le lobe profond étant masqué par les structures osseuses.
- Intérêt dans la pathologie tumorale (différencie les tumeurs intraglandulaires des tumeurs juxta-glandulaires).
- Elle peut visualiser des calculs suffisamment volumineux.
- Elle ne présente aucun intérêt dans les pathologies inflammatoires ou dans les maladies de système intéressant la parotide.



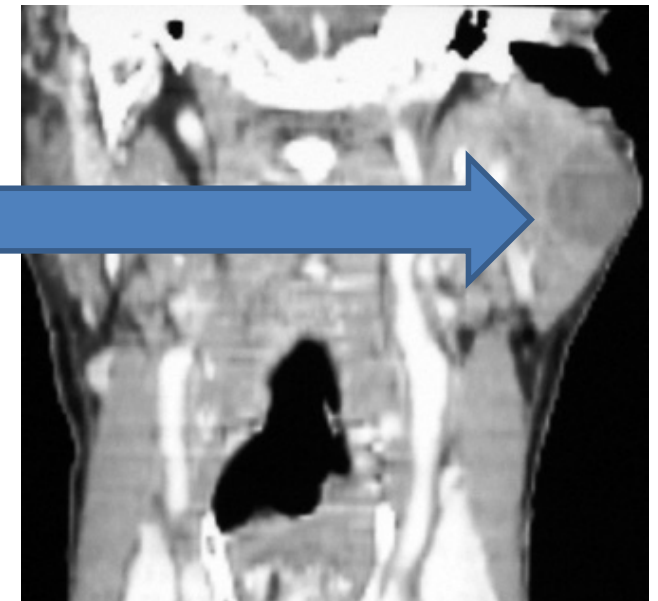
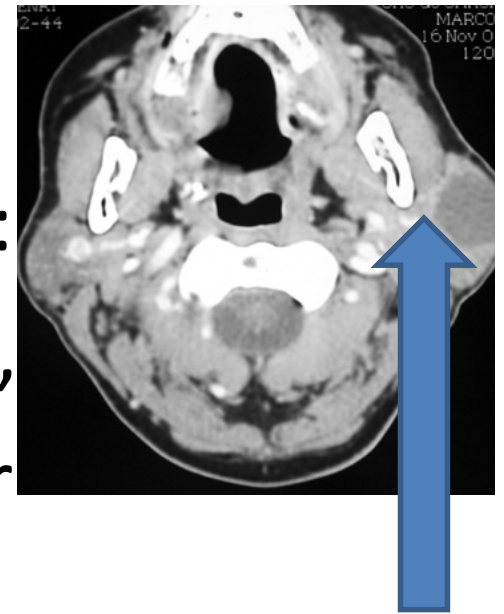
IV- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

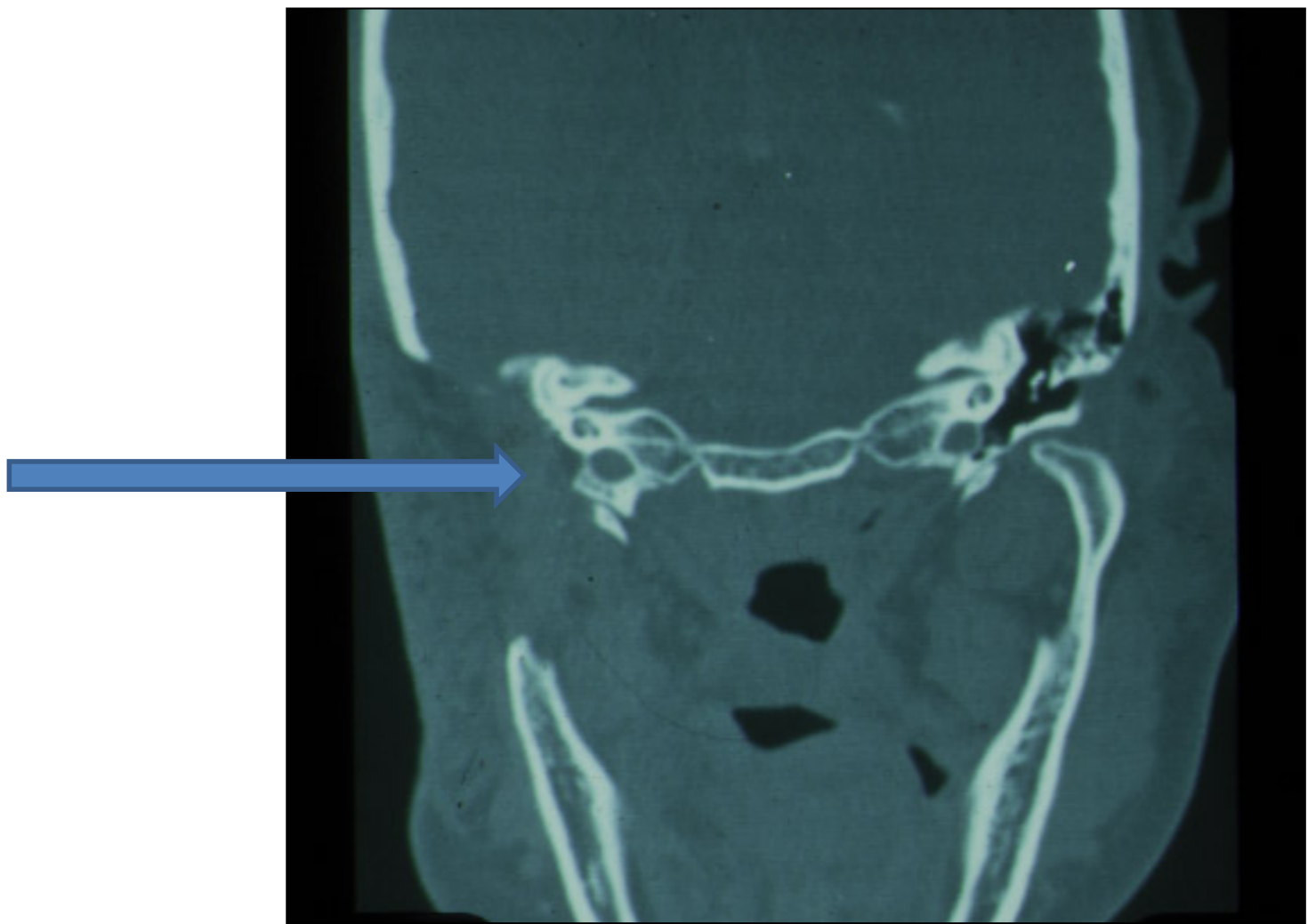
5- Examen tomodensitométrique :

- Indiqué dans la pathologie tumorale, en cas d'incertitude à l'échographie sur l'extension tumorale.

- Permet l'exploration du lobe profond de la parotide et l'analyse de l'extension aux structures avoisinantes,

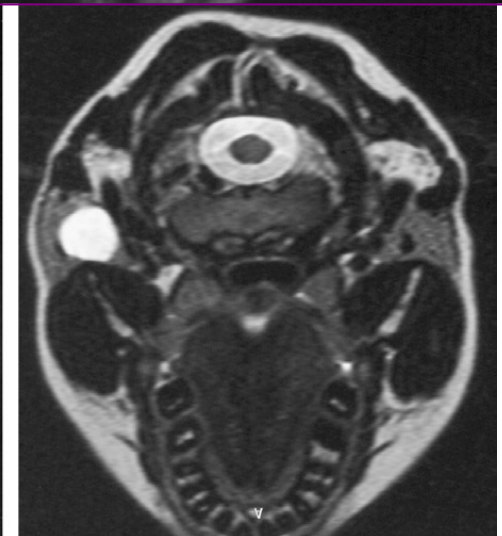
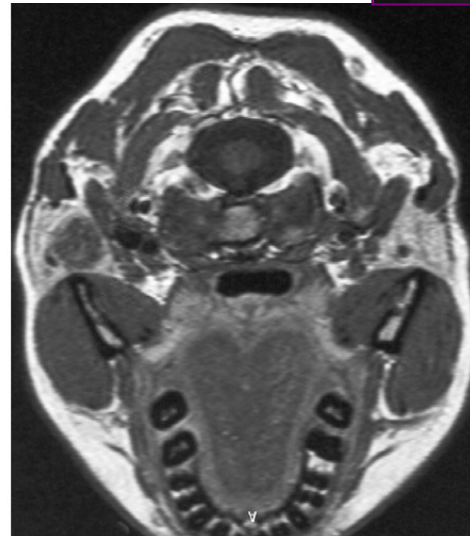
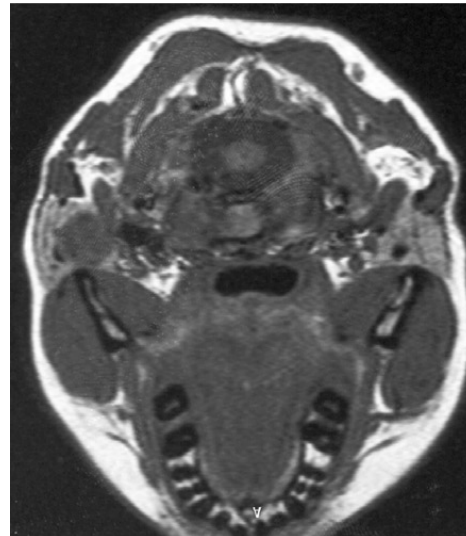
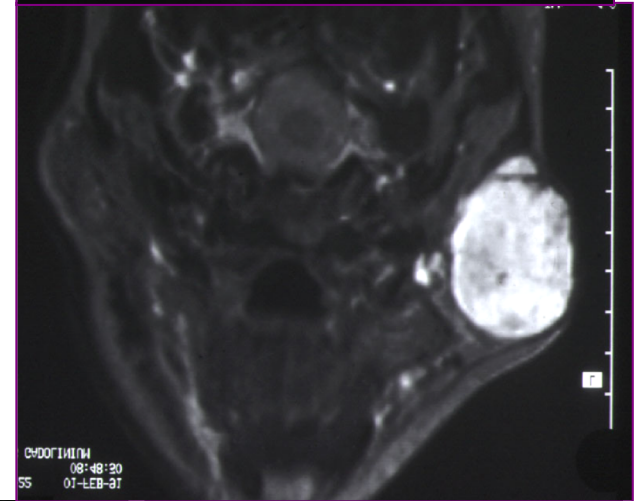
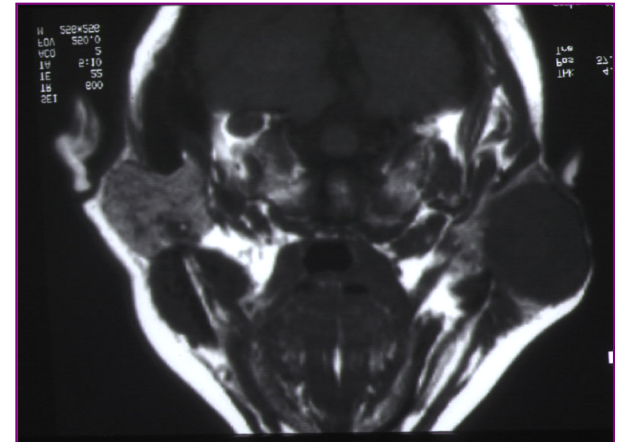
- Il présente peu d'intérêt en cas de pathologie non tumorale.

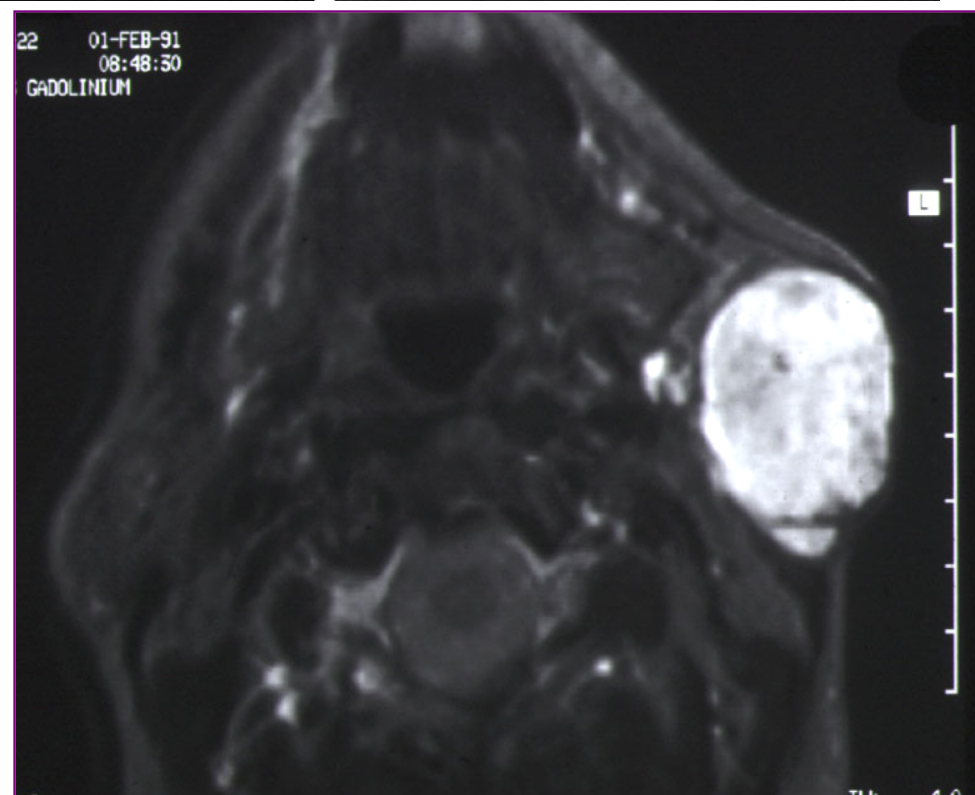
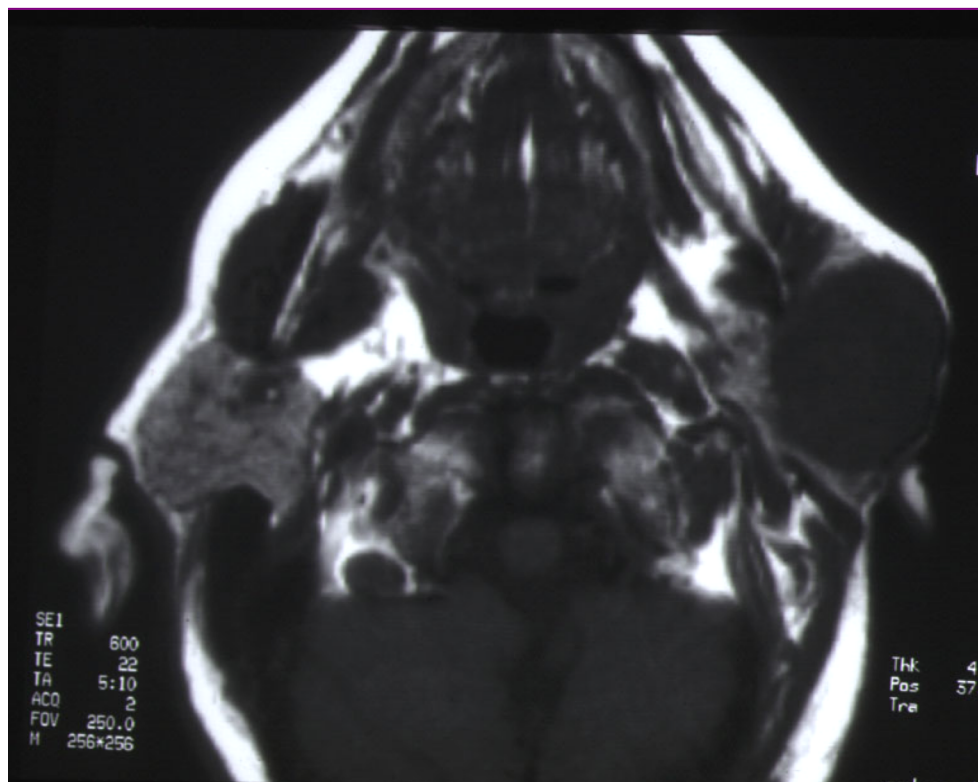
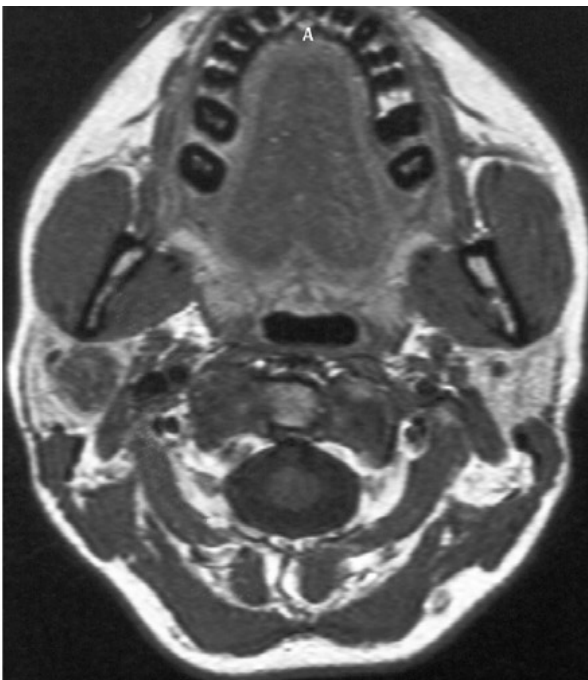
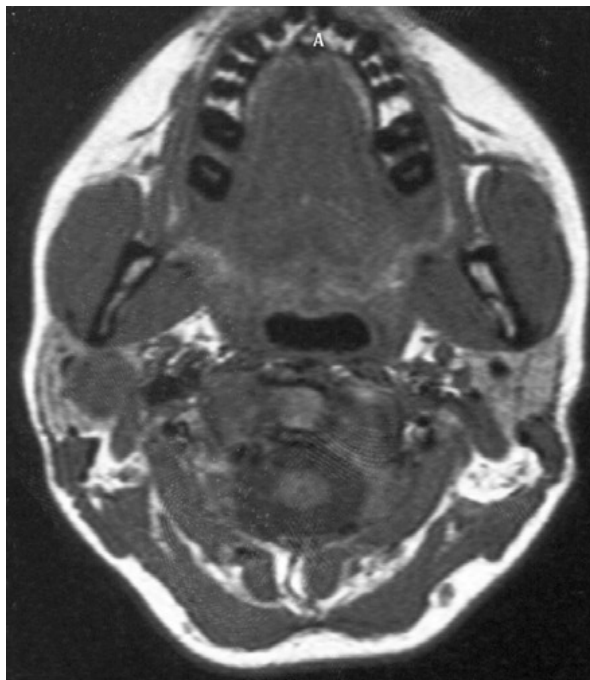




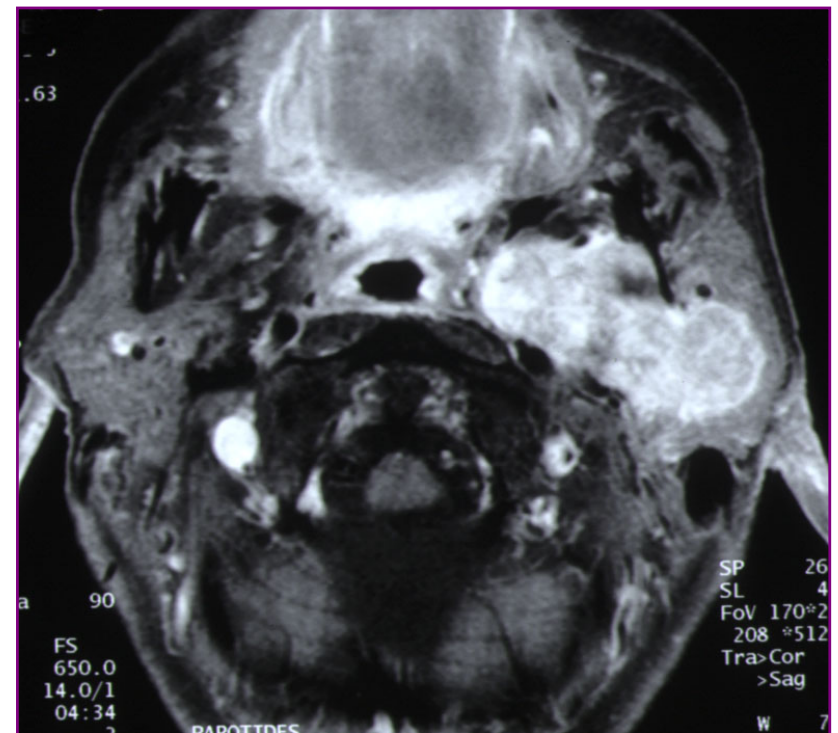
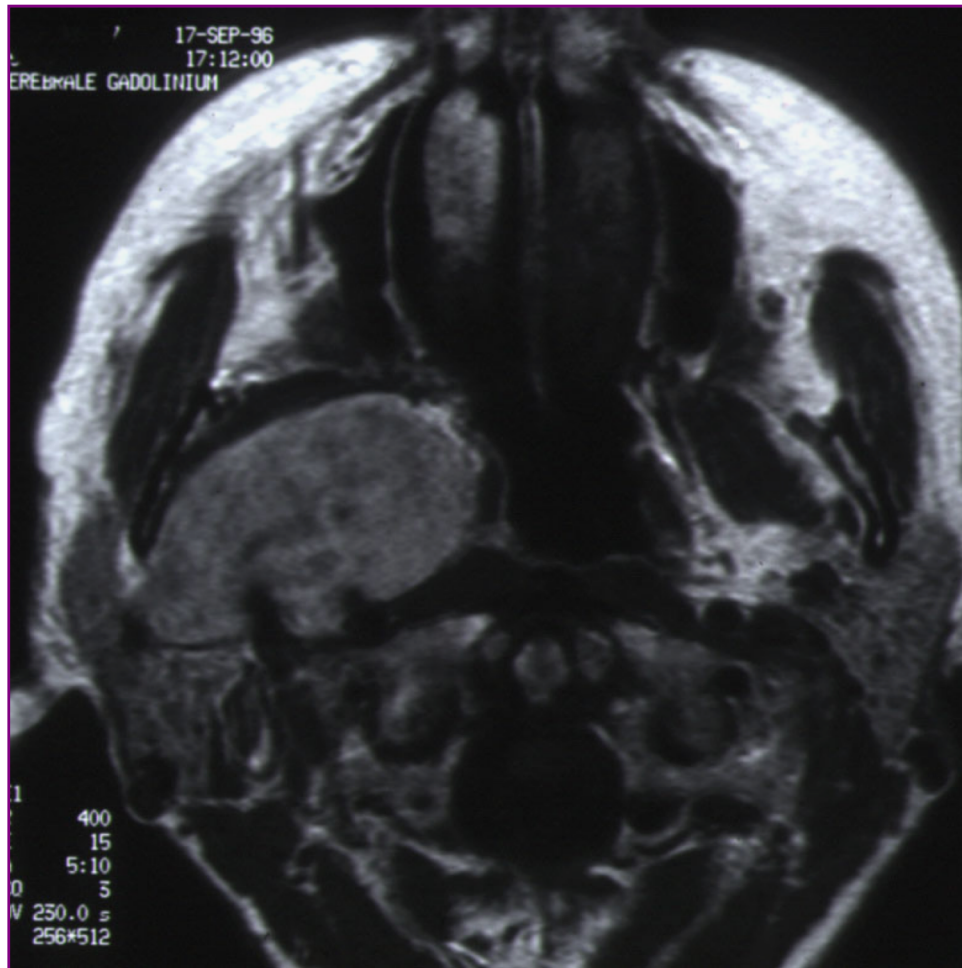
IV- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

6- IRM : elle est intéressante dans la pathologie tumorale, avec une résolution tissulaire supérieure à celle du scanner.





Tumeur du lobe profond ?



V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

A. TUMEURS

1. CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE DE L'OMS 1991

Les tumeurs sont classées en épithéliales et non épithéliales

a. Tumeurs épithéliales : 80%

Tumeurs bénignes : les adénomes :

- L'adénome pléomorphe 50%
- Tumeur de Warthin (cystadénolymphome) 10-15%
- Myoépithéliome 10-15%
- Oncocytome 5-10%
- Autres : L'adénome à cellules basales, les adénomes monomorphes

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

Tumeurs malignes : les carcinomes:

- Les adénocarcinomes ;
- Les carcinomes adénoïdes kystiques (2 à 4%) ;
- Les carcinomes muco- épidermoïdes (5 à 20%) ;
- Les carcinomes à cellules acineuses (2 à 5%) ;
- Les carcinomes épithélio-myoépithélial,
- Les carcinomes épidermoïdes ;
- Les carcinomes à cellules basales ;
- Les cystadénocarcinomes
- Les carcinomes canauxaux
- Carcinomes à petites cellules ;
- Les carcinomes indifférenciés, adénosquameux, sébacés ;

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

b. Tumeurs non épithéliales : 20%

Tumeurs conjonctives non lymphoïdes :

– Tumeurs bénignes

- Lipome
- Angiome, lymphangiome
- Neurofibrome, neurinome (shwannome)

– Tumeurs malignes

- Histiocytofibrome malin
- Hémangiopéricytome
- Rhabdomyosarcome
- Schwannome malin
- mélanome

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

Lymphome :

- Les lymphomes malins non Hodgkinien
- Les lymphomes malins Hodgkinien

Tumeurs secondaires à :

- Carcinome épidermoïde
- Mélanome
- Métastases (carcinome bronchique à petite cellule, cancer du rein, cancer du sein)

Lésions apparentées :

Sialose, lésion lymphoépithéliale bénigne, kyste salivaire

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE:

2. TUMEURS BÉNIGNES:

- L'adénome pléomorphe est le plus fréquent .
- Les autres tumeurs bénignes (dominées par le cystadénolymphome (10 à 15%).
- Découvertes devant une tuméfaction parotidienne unilatérale et isolée, lisse ou parfois bosselée, ferme ou dure, indolore, mobile par rapport à la peau et au plan profond, sans paralysie faciale associée.
- Pas d'adénopathie cervicale satellite.
- Tableau clinique est évocateur d'une tumeur bénigne,

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

2. TUMEURS BÉNIGNES

a. Adénomes pléomorphes -(tumeur mixte)

- A tout âge,
- Surtout chez la femme .
- Bosselé et dur: faveur du diagnostic.
- IRM +++
- Histologie: éléments épithéliaux et mésenchymateux.
- L' évolution spontanée: l'augmentation de volume, avec risque de dégénérescence maligne.
- Trt: chirurgical

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

2. TUMEURS BÉNIGNES

b. Cystadénolymphomes

- Homme +++, 60 et 70 ans
- Tumeur bien limitée, superficielle, postéro-inférieure,
- Evolution lente avec parfois des poussées inflammatoires.

c. Adénomes oncocytaires

- surtout après 50 ans et chez la femme, proches cliniquement de l'adénome pléomorphe.

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

3. TUMEURS MALIGNES:

a. Carcinomes adénoïdes kystiques:

- Femme +++, 50 et 60 ans.
- Ont tendance à suivre les nerfs en les infiltrant+++
- Douleurs associées à la tuméfaction (inconstante mais évocatrice)
- Douleurs à type de décharge électrique lors de la palpation tumorale +++
- Evolution: lente,
- Risque de récurrence locale, ganglionnaire ou la survenue de métastases(pulmonaires+++).
- Pronostic: péjoratif (70% de survie à 5 ans, 20% à 20 ans).

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

3. TUMEURS MALIGNES:

b. Tumeurs muco-épidermoïdes :

- Parfois associées à des douleurs
- Risque surtout local, récurrence après exérèse.
- Pronostic dépend du grade histologique.

c. Carcinomes à cellules acineuses:

- A tout âge, la femme +++.
- Evolution est lente,
- Pas de critère pronostique histologique.
- Récidives locales ou ganglionnaires peuvent survenir tardivement.
- Les métastases sont rares.

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

4. CONDUITE À TENIR DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

- Obtenir un diagnostic de nature de la tumeur.
- Parotidectomie exploratrice avec examen extemporané.
- Toute tumeur parotidienne impose une parotidectomie .
- Prévenir le patient des modalités de l'intervention chirurgicale et des risques de complications :
 - + Une paralysie ou une parésie faciale sont en général transitoires, sauf en cas de section du nerf facial accidentelle ou de nécessité ;
 - + Le syndrome de Frey est représenté par une sudation temporale lors des repas ou d'une stimulation salivaire (de survenue inconstante et imprévisible)
 - + Dépression résiduelle de la région parotidienne
 - + Insensibilité de la région auriculaire est de récupération aléatoire et tardive.

LES INTERVENTIONS

- **Sur la parotide**

- Parotidectomie exo-faciale.
- Parotidectomie totale avec conservation du facial.
- Parotidectomie totale sans conservation du facial.
- Parotidectomie élargie.

- **Sur le facial**

- Pas de sacrifice systématique.
- Résection à la demande.
- Reconstruction systématique.

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES **DEVANT UNE TUMÉFACTION** **PAROTIDIENNE UNILATÉRALE**

B. PAROTIDITES

1. PAROTIDITES AIGUES VIRALES

- La parotidite ourlienne+++,
 - le plus souvent chez l'enfant ou l'adulte jeune.
- Les signes fonctionnels: douleur de la région parotidienne irradiée à l'oreille, augmentée par la mastication associée à une hyperthermie.
- Unilatérale au début, se bilatéralise en 2 à 3 jours ;

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

B. PAROTIDITES

1. PAROTIDITES AIGUES VIRALES

- A l'examen on note :
 - Peau en regard luisante
 - Une tuméfaction parotidienne inflammatoire, rénitente, sensible à la palpation,
 - ADP parotidienne ou sous-maxillaire parfois associée ;
 - L'orifice du canal de Sténon rouge avec salive mais claire.
 - Biologique: Lymphocytose avec mononucléose, l'amylasémie est élevée.
 - La sérologie: élévation du taux des anticorps

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

B. PAROTIDITES

2. PAROTIDITES AIGUES BACTÉRIENNES

- Les signes fonctionnels sont représentés par une douleur vive et un léger trismus.
- Les signes généraux sont marqués avec fièvre et asthénie intense.

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

B. PAROTIDITES

2. PAROTIDITES AIGUES BACTÉRIENNES

A l'examen on retrouve :

- Une tuméfaction parotidienne inflammatoire ;
- Une douleur provoquée intense ;
- L'orifice du canal de Sténon turgescent avec issue de salive purulente.
- Sur le plan biologique, il existe une hyperleucocytose avec polynucléose.
- Le traitement: antibiotique doit être rapidement instauré.

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

B. PAROTIDITES

3. PAROTIDITES BACTÉRIENNES CHRONIQUES NON SPÉCIFIQUES

- Plus fréquentes chez l'enfant (peuvent survenir chez l'adulte mais en général bilatérales).
- Se manifestent sous la forme de poussées de parotidites aiguës récidivantes.
- La sialographie est évocatrice et retrouve des images arrondies, en « plomb de chasse », qui persistent aux clichés en évacuation, les canaux salivaires sont normaux.

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

B. PAROTIDITES

4. PAROTIDES CHRONIQUES SPÉCIFIQUES

- Parotidite tuberculeuse: sous la forme d'un nodule froid intraparotidien, parfois sensible, avec ramollissement en son centre et adhérence à la peau.
- IDR, Radiographie pulmonaire,
- Ponction pour culture sur milieu spécifique aidant au diagnostic, qui n'est parfois posé que sur l'examen anatomopathologique.

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

B. PAROTIDITES

5. LITHIASES DE LA PAROTIDE

- Moins fréquente au niveau de la glande parotide
- Ses manifestations sont plus souvent infectieuses que mécaniques.
- Au point de vue fonctionnel, les manifestations mécaniques sont de deux ordres :
 - **La hernie parotidienne** : survenue brutale, lors d'un repas, d'une tuméfaction parotidienne qui disparaît rapidement après un bref écoulement de salive ;

V- ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE UNILATÉRALE

B. PAROTIDITES

5. LITHIASES DE LA PAROTIDE

La colique salivaire :

- Même tableau clinique avec l'association à la tuméfaction parotidienne d'une douleur intense.
- Les manifestations infectieuses sont représentées par la parotidite suppurée ou non, parfois récidivante.
- A l'examen, la glande parotide est parfois encore tuméfiée. L'ostium du canal de Sténon est rouge, tuméfié, non purulent.
- Les radiographies sans préparation recherchent le calcul.
- La sialographie retrouve parfois la lacune due au calcul, et surtout une dilatation du canal en amont de l'obstacle.

VI- ORIENTATION DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE BILATÉRALE.

A. TUMÉFACTIONS PAROTIDIENNES AU COURS DES MALADIES DE SYSTÈME

1. SARCOÏDOSE

- Tuméfaction parotidienne: indolore, bilatérale,
- Installation rapide et de régression spontanée.
- Association: parotidite, paralysie faciale et uvéite= Syndrome de Heerfordt.
- Association: atteinte parotidienne, sous-mandibulaire et lacrymale = Syndrome de Mikulicz.

VI- ORIENTATION DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE BILATÉRALE.

A. TUMÉFACTIONS PAROTIDIENNES AU COURS DES MALADIES DE SYSTÈME ET HÉMATOLOGIQUE

2. SYNDROME DE GOUGEROT- SJÖGREN

- La tuméfaction parotidienne est indolore, d'installation lente, .
- En général inhomogène et indurée au stade de sclérose glandulaire.
- Rechercher une sécheresse buccale et oculaire.

VI- ORIENTATION DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE BILATÉRALE.

A. TUMÉFACTIONS PAROTIDIENNES AU COURS DES MALADIES DE SYSTÈME ET HÉMATOLOGIQUE.

3. LEUCÉMIES

Au cours des leucémies lymphoïdes chroniques, une tuméfaction parotidienne indolore et bilatérale peut être isolée ou s'intégrer dans le cadre d'un syndrome de Mikulicz. Au cours des leucémies aiguës, une tuméfaction parotidienne peut être en rapport avec une infiltration leucémique ou une infection virale dans le cadre d'une immuno-dépression.

VI- ORIENTATION DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE BILATÉRALE

B. PAROTIDOMÉGALIE NUTRITIONNELLES

1. PAR EXCÈS

Excès de consommation d'hydrates de carbone, diabète, obésité, éthylisme chronique.

2. PAR CARENCE

Grandes malnutritions, anorexie mentale.

C. PAROTIDITES CHRONIQUES D'ORIGINE TOXIQUE

Certaines intoxications chroniques sont responsables d'une tuméfaction parotidienne sensible : plomb, pesticides, insecticides, iodures.

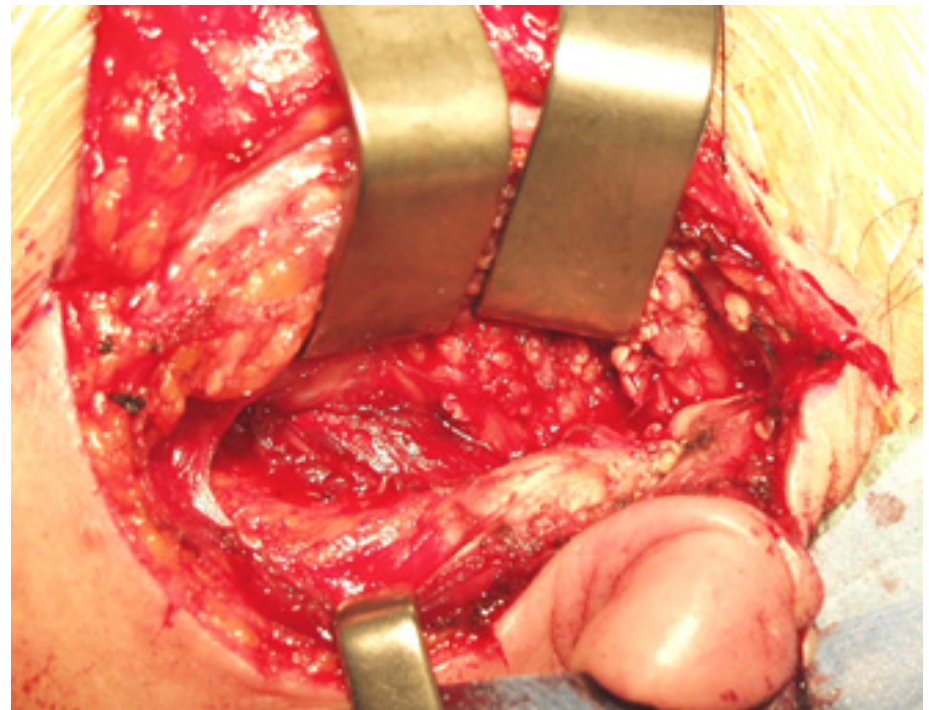
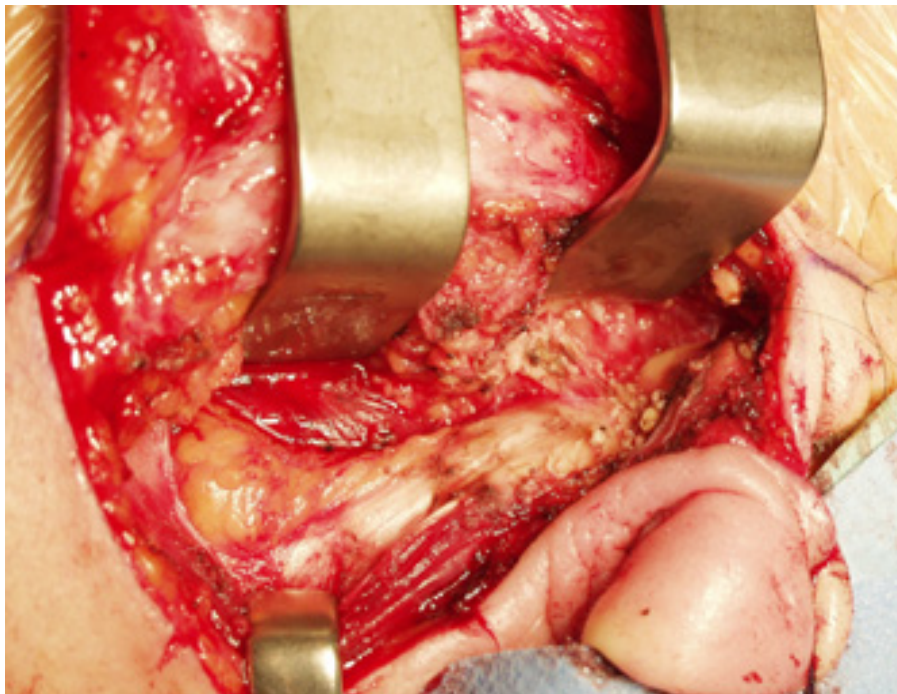
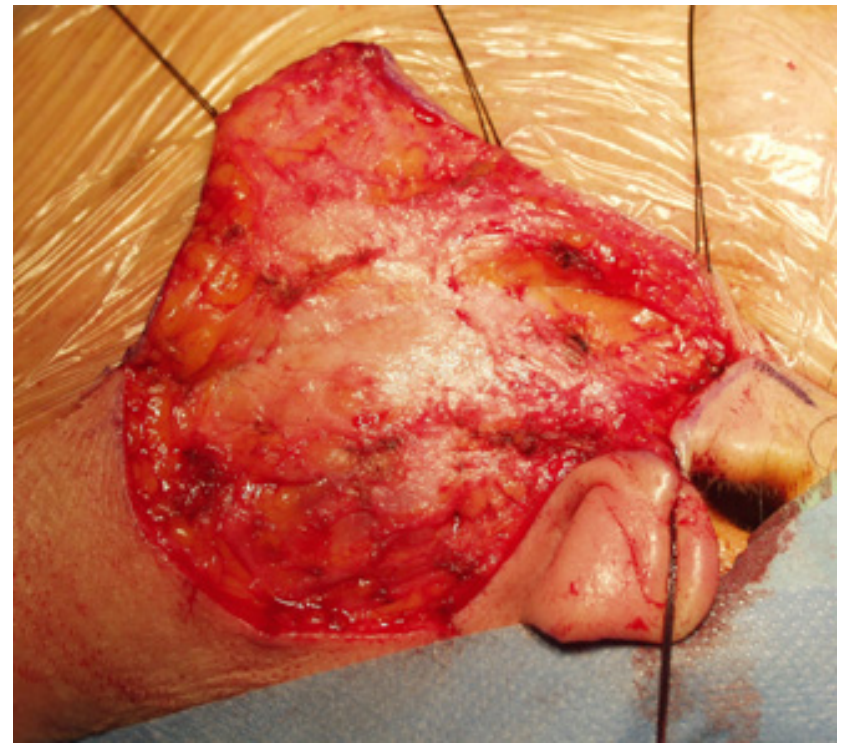
VI- ORIENTATION DIAGNOSTIQUES DEVANT UNE TUMÉFACTION PAROTIDIENNE BILATÉRALE

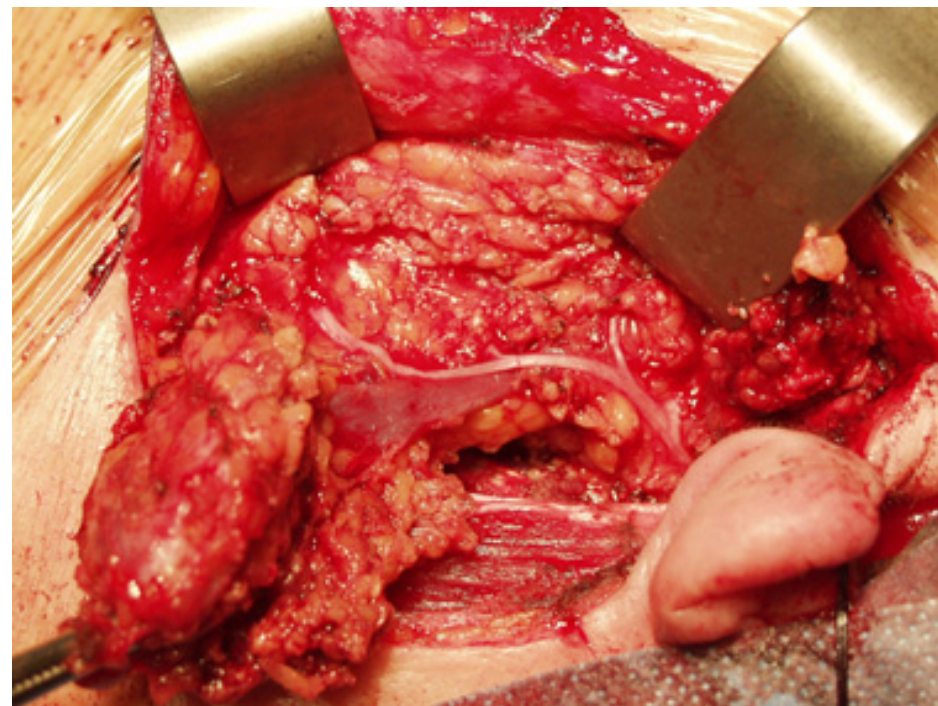
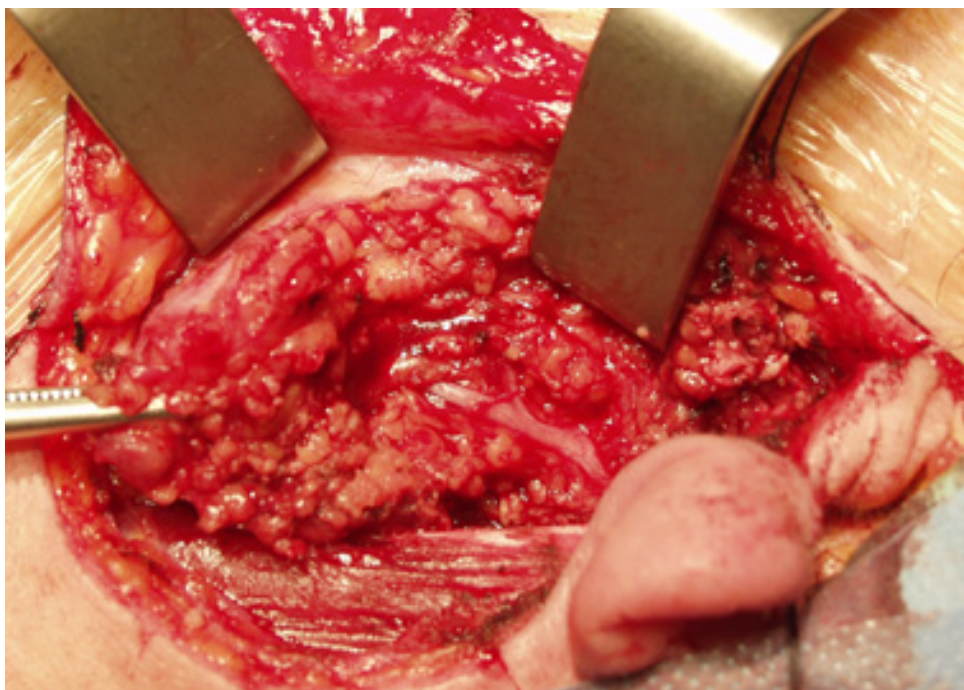
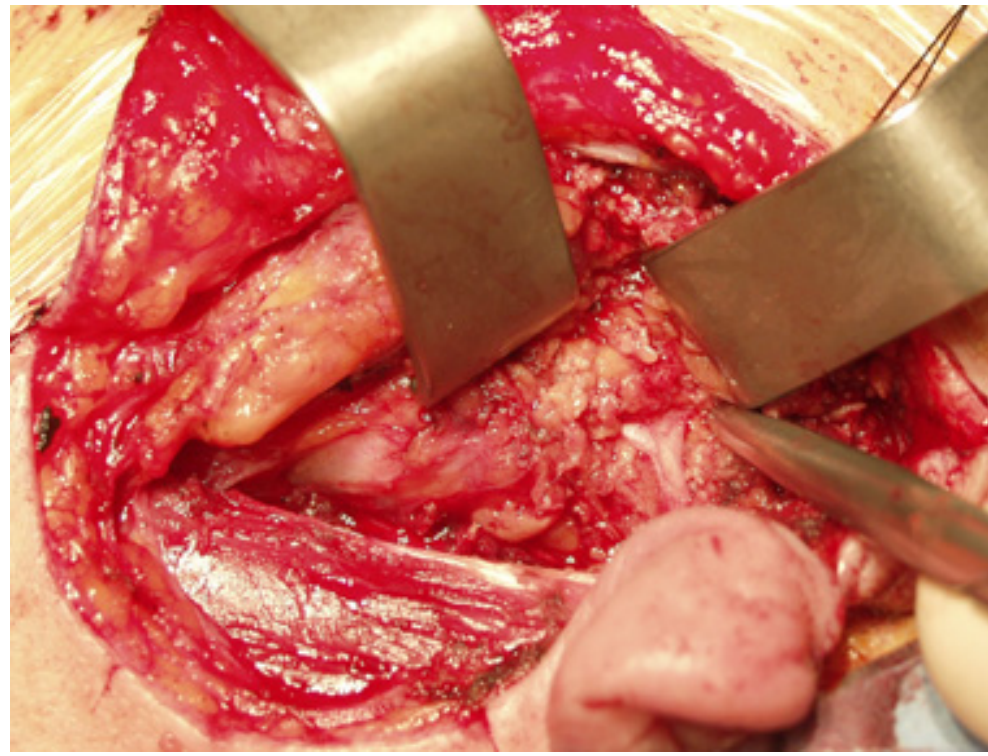
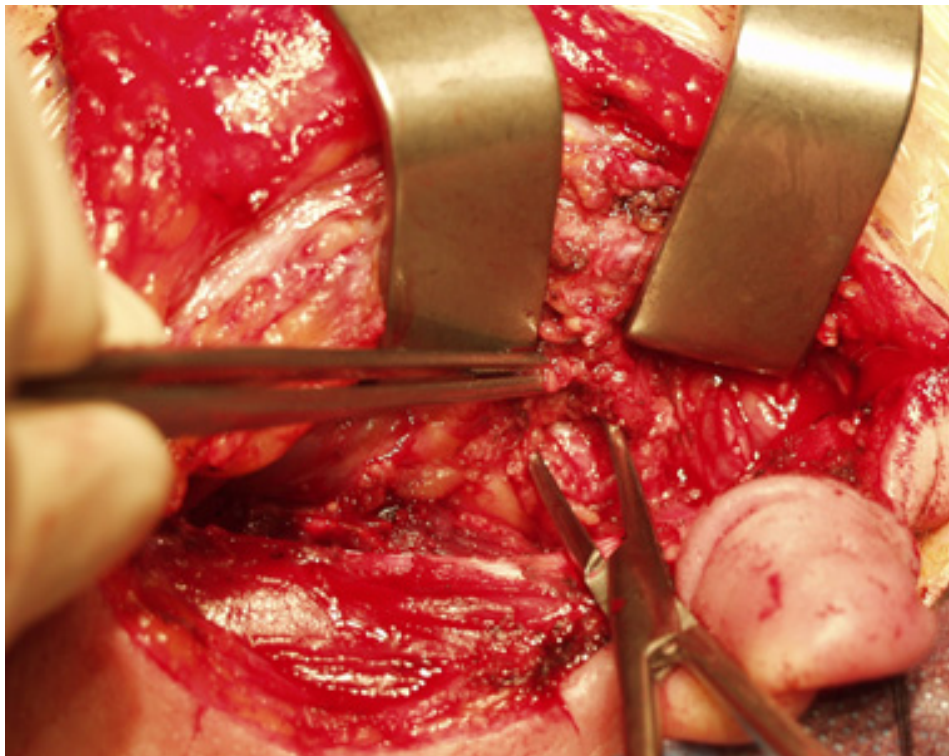
D. CALCINOSE SALIVAIRE

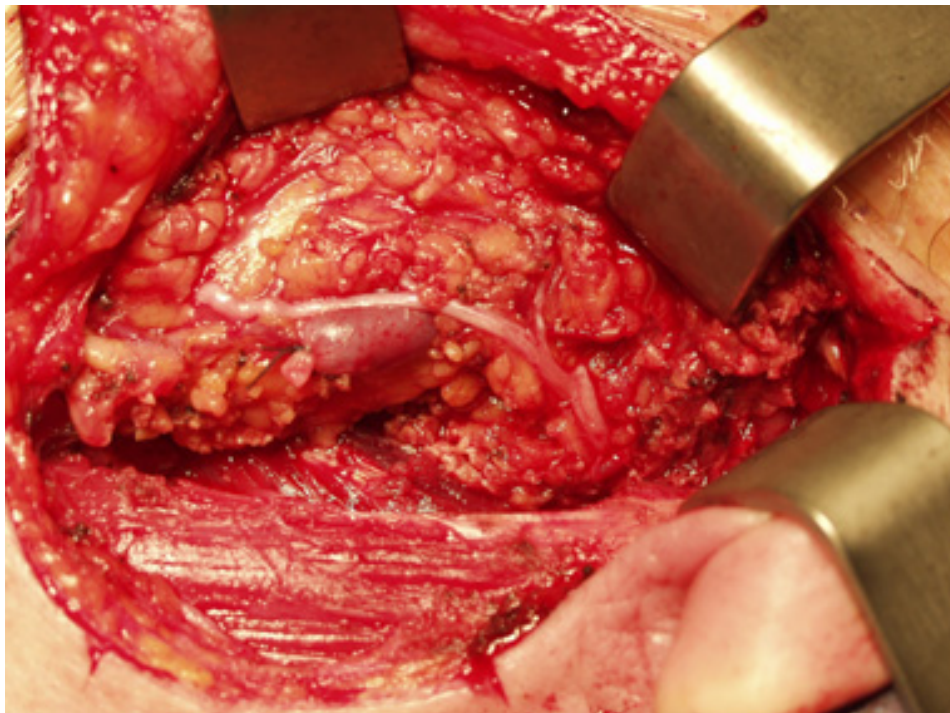
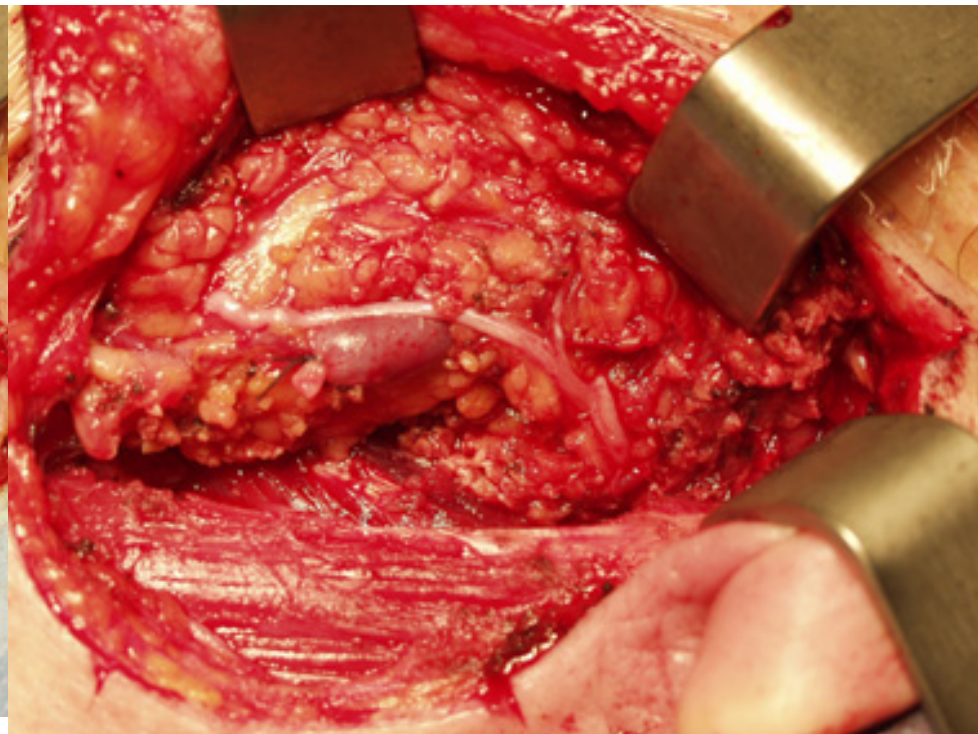
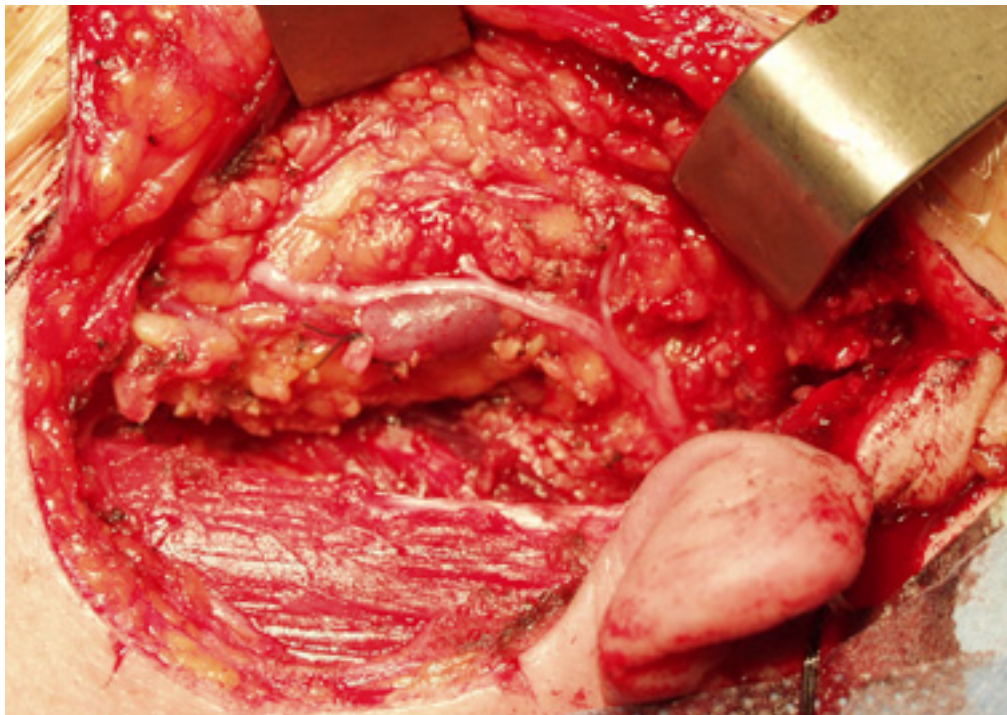
- Parotidite chronique bilatérale ou à bascule,
- Tuméfaction parotidienne douloureuse intermittente, salive séropurulente.
- Femmes de la cinquantaine,
- Présence de multiples calcifications intracanalaires.
- Radiographies sans préparation: calcifications au niveau des deux parotides.
- Sialographie: Images arrondies, des canaux légèrement dilatés.

- CONCLUSION:

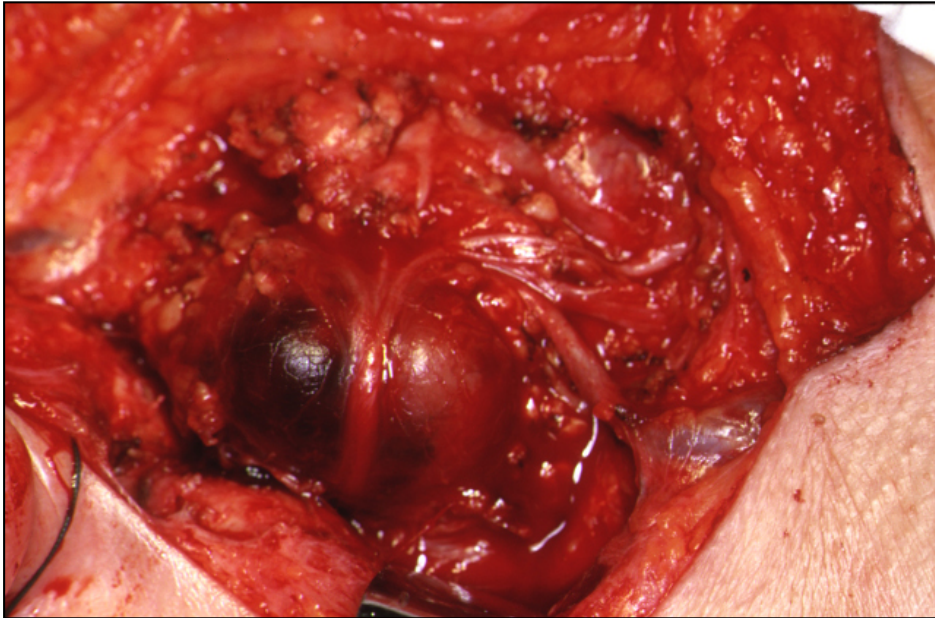
- Une tuméfaction parotidienne unilatérale doit faire évoquer en premier lieu une tumeur.
- Une tuméfaction parotidienne bilatérale doit faire évoquer en premier lieu une maladie de système.
- Une tuméfaction parotidienne unilatérale doit être opérée, les tuméfactions parotidiennes bilatérales ne sont, en général, pas chirurgicales.
- En cas de pathologie tumorale, il ne faut jamais réaliser de tumorctomie ou d'énucléation, mais toujours une parotidectomie totale ou subtotale.
- Il ne faut pas multiplier inutilement les examens complémentaires.







Parotidectomie avec préservation du nerf facial



Indication : Tumeur endo-faciale